

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re A

Amélioration de la santé reproductive

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche propose des situations complexes mobilisant l'ensemble des connaissances du module pour argumenter, décider et proposer des stratégies d'intervention en santé reproductive.

EXERCICE 1 Analyse critique des grossesses précoces : approche médico-sociale

Une étude transversale réalisée dans une zone urbaine camerounaise révèle que 28% des filles âgées de 15 à 19 ans ont déjà commencé leur vie féconde. Les données obstétricales montrent une incidence multipliée par 3,5 des fistules obstétricales et par 2,8 des accouchements par césarienne d'urgence chez les <18 ans par rapport aux 20–24 ans. Parallèlement, l'enquête EDS-MICS indique que 65% de ces grossesses sont déclarées « non désirées » ou « mal espacées ».

1. En vous appuyant sur la physiologie de la puberté et de la maturation du bassin, expliquez les mécanismes anatomiques et physiologiques qui fondent le risque accru de dystocie fœto-pelvienne et de fistules vésico-vaginales chez l'adolescente de <18 ans. (2 pts)
2. Analysez les conséquences biologiques (sur la mère et le nouveau-né), psychologiques et socio-économiques à court, moyen et long terme d'une grossesse précoce non désirée, en distinguant les effets directs des effets induits par la rupture de la scolarisation. (2 pts)
3. À partir du concept de « besoins non satisfaits en planification familiale », proposez une argumentation structurée pour justifier l'accès aux contraceptifs modernes aux adolescents, en intégrant la notion de consentement éclairé et le cadre légal camerounais (loi n°2018/011). (2 pts)

EXERCICE 2 Stratégies de prévention des IST/VIH : évaluation comparative

Le tableau ci-dessous synthétise des données épidémiologiques et préventives pour quatre IST majeures au Cameroun.

IST / Pa- ra- mètre	VIH-1	HPV (HR)	Neisseria gonorrhoeae
Mode de transmission principal	Sexuel, sanguin, materno-fœtal	Sexuel (muqueuses/peau)	Sexuel (muqueuses)
Prévention vaccinale	Non	Oui (2/4/9 valent)	Non
Dépistage systématique pré-natal	Oui	Non	Non (symptomatique)
Traitement curatif	ARV à vie (suppression)	Non (lésions précancéreuses)	Antibiotiques (résistance ↑)

1. En croisant les modes de transmission et les moyens de prévention disponibles, justifiez pourquoi le préservatif (masculin ou féminin) demeure l'unique méthode à « double protection » (grossesse + IST) efficace sur les quatre agents, alors que la PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition) ne protège que contre le VIH. (2 pts)
2. Discutez les limites stratégiques d'une politique de santé publique reposant exclusivement sur l'approche « ABC » (Abstinence, Be faithful, Condom) face à l'épidémiologie du HPV et aux résistances antibiotiques de *N. gonorrhoeae*. Proposez deux axes complémentaires fondés sur les données du tableau. (2 pts)
3. Un couple sérodifférent (Homme VIH+ sous ARV charge virale indétectable <20 copies/mL depuis 12 mois; Femme VIH-) souhaite concevoir un enfant. Argumentez, preuves scientifiques à l'appui (concept I=I), sur la pertinence médicale et éthique de

la conception naturelle versus l'insémination artificielle avec lavage du sperme. (2 pts)

EXERCICE 3 Choix contraceptif : raisonnement décisionnel et conseil

Trois patientes consultent au Centre de Santé de la Reproduction pour une première prescription contraceptive.

- Patiente A : 17 ans, nullipare, vie sexuelle débutante (1 partenaire), antécédents de migraine avec aura, fumeuse (5 cig/jour), refuse tout examen gynécologique.
 - Patiente B : 32 ans, 3 enfants (dernier 6 mois), allaitement exclusif, antécédent de thrombose veineuse profonde (TVP) post-partum il y a 2 ans (non traitée actuellement), désire méthode « oubliée » et réversible à 2 ans.
 - Patiente C : 42 ans, 4 enfants, hypertendue traitée (IRC stade 2), diabète type 2 équilibré, refuse méthode hormonale et méthode chirurgicale définitive, cycle régulier 28 jours.
1. Pour chaque patiente, identifiez les contre-indications absolues (Catégorie 4 OMS/MEC) et relatives (Catégorie 3) aux méthodes œstro-progestatives (pilule combinée, patch, anneau) et aux méthodes progestatives seules (pilule microdose, implant, DIU hormonal, injectable). Présentez votre analyse sous forme de tableau synthétique. (2 pts)
 2. Sélectionnez la méthode optimale pour chaque patiente. Justifiez rigoureusement votre choix par : le mécanisme d'action principal, l'indice de Pearl (usage parfait vs usage typique), la prise en charge des effets secondaires prévisibles, et la compatibilité avec le mode de vie/antécédents. (2 pts)
 3. Pour la Patiente C, détaillez le protocole d'apprentissage et les critères de fiabilité de la méthode symptothermique (double check) choisie. Calculez la fenêtre fertile théorique pour un cycle de 28 jours (ovulation J14, durée de vie spermatozoïdes 5 jours, ovocyte 24h) et discutez de l'impact d'un cycle court (24 jours) sur la sécurité de la méthode. (2 pts)

EXERCICE 4 Conception d'une intervention intégrée en santé reproductive des adolescents

Vous êtes chargé(e) de concevoir le volet « Santé Reproductive » du Plan Communal de Développement (PCD) pour une commune rurale à forte prévalence de mariages précoces (<18 ans : 40% des filles) et de faible taux de fréquentation des services de santé par les jeunes (12%).

1. Identifiez trois déterminants sociaux, culturels et structurels (barrières) spécifiques à ce contexte qui expliquent la faible utilisation des services de planification familiale et

de dépistage IST par les adolescents. (1 pt)

2. Proposez un paquet d'activités intégré (minimum 5 actions) articulant : éducation sexuelle complète (ESC) en milieu scolaire et hors scolaire, offre de services « amis des jeunes » (critères OMS), mobilisation communautaire (leaders religieux/traditionnels), et plaidoyer auprès des décideurs locaux. Pour chaque action, précisez l'indicateur de résultat (SMART) et l'acteur responsable. (3 pts)
3. Élaborez une grille d'évaluation de la « qualité du conseil contraceptif » à destination des prestataires de santé, intégrant les 5 étapes de la méthode GATHER (Greet, Ask, Tell, Help, Explain, Return) et les droits des patients (information, choix libre, confidentialité, consentement). (2 pts)